

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Fallbesprechung	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: alle

Definition

- Eine Fallbesprechung ist eine Versammlung mehrerer Pflegekräfte, dessen zentrales Thema die Pflegesituation eines bestimmten Patienten ist. Moderiert wird eine Fallbesprechung von der Teamleitung oder der Bezugspflegekraft.
- Wir verstehen Fallbesprechungen als ein zentrales Instrument zur Sicherung der internen Qualität. Fallbesprechungen dienen dazu, dass alle beteiligten Mitarbeiter einen einheitlichen Wissensstand zu Pflegeproblemen und zu Ressourcen jedes Patienten haben. Gleichzeitig gilt es, gemeinsame Lösungsstrategien zu entwickeln, die vom gesamten Team mitgetragen werden.
- Fallbesprechungen sind geeignete Instrumente, um neu eingestellte Pflegekräfte oder Auszubildende mit der Pflegesituation einzelner Patienten vertraut zu machen.
- Dieses ist insbesondere wichtig bei Krankheitsbildern wie Demenz, die mit herausforderndem und risikogoneigtem Verhalten verbunden sind. Da hier Sichtweisen verschiedener Mitarbeiter zusammengefügt werden, entsteht häufig für alle ein ganz neues Bild von der Realität des Pflegebedürftigen.
- In den meisten Fällen kristallisieren sich dann ganz von allein konkrete Strategien und Maßnahmen heraus, die dann vom ganzen Team mitgetragen werden.
- Im Gegensatz zu einer Pflegevisite wird eine Fallbesprechung ohne den Patient, dafür aber ggf. mit anderen Professionen und Funktionsbereichen durchgeführt.

Grundsätze

Fallbesprechungen leben von den unterschiedlichen Wahrnehmungen und Erfahrungen aller Teilnehmer. Die Beiträge aller Mitarbeiter können dabei durchaus subjektiv gefärbt sein. Auch kleine und unscheinbare Informationen können relevant sein.

Für alle Pflegekräfte sind die in einer Fallbesprechung definierten Maßnahmen bindend, sobald diese in der Maßnahmenplanung eingetragen sind. Eine Pflegekraft weicht davon nur ab, wenn dieses zwingend notwendig ist; also etwa, falls die Gesundheit eines Pflegebedürftigen bedroht ist. Die individuelle Verantwortung jeder Pflegekraft für ihr persönliches Verhalten bleibt also erhalten.

Ziele

- Jeder Patient wird regelmäßig zum Thema einer Fallbesprechung.
- Alle für die Pflege relevanten Informationen werden ausgetauscht.
- Gemeinsam werden Ideen, Vorschläge und Lösungswege erarbeitet.
- Denkblockaden in Problemsituationen werden im gemeinsamen Gespräch bewusst gemacht und abgebaut.
- Die Wirksamkeit von Behandlungsstrategien wird überprüft.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	31.03.2023		1	1/1	Verw./MA

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Fallbesprechung	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: alle

- Arbeitsabläufe bei der Versorgung eines Patienten werden optimiert.
- Die Patientenzufriedenheit und die Mitarbeiterzufriedenheit werden gesteigert.

Vorbereitung

- Die Fallbesprechung kann zeitlich an die Teambesprechung gekoppelt werden. Wenn eine Fallbesprechung mit der Teambesprechung verbunden wird, sollte die Teambesprechung auf das Wesentliche beschränkt werden, damit für die Fallbesprechung mehr Zeit bleibt.
- Fallbesprechungen erfolgen zudem zur Vorbereitung einer Begutachtung zur Vergabe eines Pflegegrads. Sie können auch angesetzt werden, wenn sich der Zustand eines Patienten kurzfristig verändert hat und die Pflege neu ausgerichtet werden muss. Ein weiterer Anlass für eine Fallbesprechung sind berechnete Beschwerden etwa durch Angehörige.
- Von erheblicher Bedeutung sind Fallbesprechungen bei ethischen Problemen mit erheblicher Tragweite. Innerhalb des rechtlichen Entscheidungsraums können Pflegekräfte eine gemeinsame Problemlösung entwickeln. Ein Beispiel: Ein alkoholkranker Patient möchte, dass Pflegekräfte für ihn Spirituosen kaufen.
- Die Moderation sollte von der Bezugspflegekraft übernommen werden. Alternativ fungiert die Pflegedienstleitung als Moderator.
- Die Pflegedokumentation liegt für jeden einsehbar während der Fallbesprechung auf dem Tisch. Es ist wichtig, dass alle relevanten Unterlagen bereitliegen. Wenn eine Fallbesprechung aufgrund fehlender Informationen abgebrochen werden muss, ist das für alle Beteiligten sehr frustrierend.
- Es sollte sichergestellt sein, dass alle Beteiligten pünktlich erscheinen und bis zum Ende der Fallbesprechung bleiben können. Ein ständiges Kommen und Gehen ist zu vermeiden.

Durchführung

Es ist sinnvoll, die Fallbesprechung inhaltlich zu gliedern. Etwa:

- Der Moderator stellt den Patient vor und fasst die wesentlichen Fakten zu seinem Krankheitsbild und den verbliebenen Ressourcen zusammen. Er stützt sich dabei auch auf die Pflegedokumentation; insbesondere auf die Maßnahmenplanung. Relevant sind zudem auch juristische Aspekte wie etwa eine bestehende Betreuung oder Vorgaben zur Fixierung.
- Der Moderator erklärt, warum der Patient das Thema dieser Fallbesprechung ist. Er benennt die Probleme, die sich aus dem Gesundheitszustand des Patienten ergeben. Es können auch Hinweise von externen Personen einfließen, etwa von Angehörigen, die relevante Beobachtungen gemacht haben.
- Der Moderator trägt auch die Eigeneinschätzung des Patienten vor, soweit ihm diese bekannt ist.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	31.03.2023		1	1/2	Verw./MA

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Fallbesprechung	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: alle

- Der Moderator fragt, ob andere Teilnehmer über ergänzende Informationen zum Zustand des Patienten verfügen. Es darf in dieser "Blitzlicht-Phase" ausdrücklich neben nachprüfbaren Fakten auch das "Bauchgefühl" angesprochen werden.
- Jeder aus der Teilnehmergruppe darf nun Verständnisfragen stellen.
- Die Teilnehmer diskutieren über Faktoren, die das Problem positiv oder negativ beeinflussen.
- Gemeinsam werden die Ziele definiert. Dabei sind insbesondere diese Kriterien relevant:
 - Ist das Ziel erreichbar und wünschenswert?
 - Sind die Ziele mit realistischem Aufwand umsetzbar?
 - Wird der Patient den Zielen und den Maßnahmen zur Umsetzung zustimmen?
 - Welche Erwartungen hinsichtlich des Krankheitsverlaufs sind realistisch?
 - Der Moderator sammelt Lösungsvorschläge. Diese können auf einem Flipchart oder auf Pappkarten visualisiert werden.
- Die Teilnehmer beraten darüber, welche Ideen sich umsetzen lassen und welche Einzelschritte dafür erforderlich sind. Wir prüfen, welche anderen Funktionsbereiche (Hauswirtschaft, soziale Dienste) eingebunden werden müssen.
- Der Moderator sortiert die Ideen nach Praxistauglichkeit. Ein weiteres Kriterium ist die Priorität. Wenn also im jeweiligen Bereich dringender Handlungsbedarf besteht, hat dieses Ziel Vorrang.
- Die ersten Interventionsmaßnahmen werden geplant.
- Die Teilnehmer einigen sich auf einen Folgetermin.

An zuspreekende Themen sind

Medizinische Behandlungspflege und Zusammenarbeit mit dem Hausarzt, etwa

- aktuelle ärztliche Diagnosen
- aktueller Zustand des Patienten
- Auswirkungen des gesundheitlichen Zustands auf die Lebensqualität, etwa Schmerzen oder Mobilitätseinschränkungen
- Prognose des Hausarztes über die weitere gesundheitliche Entwicklung
- geplante medizinische Maßnahmen; etwa anstehende Operationen
- Anordnungen des Hausarztes
- erforderliche prophylaktische Maßnahmen (Dekubitus, Kontrakturen, Aspiration usw.)
- notwendige Kontrollmaßnahmen
- Informationsaustausch mit dem Hausarzt

Dokumentation:

- Fallbesprechung wird auf hauseigenen Protokoll dokumentiert

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	31.03.2023		1	1/3	Verw./MA

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Fallbesprechung	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: alle

- der Verlauf der Maßnahmen wird im Berichtsblatt 2015 so lange dokumentiert wie es in der Fallbesprechung festgelegt wurde
- die Evaluation erfolgt ebenfalls im Berichtsblatt und sollte gekennzeichnet werden(im Feld F,S,N wird hier nur FBA =Fallbesprechungsauswertung geschrieben)
- anschließend erfolgt eine Anpassung in der Akte, der gesamten Dokumentation entsprechend

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	31.03.2023		1	1/4	Verw./MA